

CARDIOPATHIES CONGENITALES

Présenté par Pr R.Lakehal



I/ Introduction

- Domaine complexe
- Gravité : mortalité 50% (1ère année)



II/ Incidence

- 7 cas/1000 naissances
- Plus fréquentes des malformations congénitales

III/ Etiologies

- *Pas de cause évidente : **90%**
- ***Cause génétique** définie : **8%**
 - Aberration chromosomique (**5%**), ex : Trisomie 21, syndrome de Turner
 - Anomalies génétiques (**3%**)
- ***Embryofœtopathie** par agent externe (**2%**)
 - Agents toxiques : alcool, ...
 - Agents nutritionnels : diabète, ...
 - Agents viraux : rougeole, rubéole, ...

IV/ Classification:

Cardiopathies non cyanogènes =

- Shunt gauche- droite : communication inter- ventriculaire, communication inter- auriculaire, persistance du canal artériel
- Obstacle sans shunt : sténose pulmonaire / aortique, coarctation de l'aorte.

Cardiopathies cyanogènes =

- Obstacles sur le cœur
- Absence ou erreur de cloisonnement
- Tétralogie de Fallot

V/ Les signes d'appel

Ils sont variables selon les cardiopathies ; l'âge de la découverte et la gravité sont variable.

1. Signes généraux

Retard du développement, asthénie anormale, ...

2. Signes fonctionnels

Dyspnée, sueurs, cyanose, douleurs précordiales, palpitations, malaises, ...

3. Signes d'examen

Découverte d'un souffle, d'une hypertension artérielle, ...

4. Echographie fœtale

Etude des ATCD, examen de l'enfant



VI/ Antécédents familiaux:

- Consanguinité
- Cardiopathie dans la famille
- Maladies héréditaires infantiles

VII/ Antécédents néonataux:

1. ATCD maternels
2. ATCD fœtaux

VIII/ Antécédents personnels:

- Circonstances de l'accouchement
- Poids de naissance
- Développement staturo-pondéral
- Développement psychomoteur

IX/ Examen de l'enfant

1. Inspection

- Syndrome dysmorphique, ...
- Signes évocateurs : cyanose, polypnée, tachypnée, ...

2.Palpation

des artères (fémorales+++)
de l'abdomen, du foie, de la rate, ...

3.Auscultation

- Rythme, bruits, souffles, ...

4.Prise de la tension artérielle

Méthode : brassard adapté / pouls, stéthoscope

Interprétation, anomalies

5.Examen général Le diagnostic de cardiopathie est fait dans **90%** des cas conduit à des examens spécialisés :

- Non invasifs

radiographie pulmonaire, ECG, échocardiographie+++, épreuve d'effort, Holter,

- Invasifs

X/ Shunts gauche- droite

1) Généralités, définition:

- *Cardiopathies non cyanogènes les plus fréquentes.
 - *Passage anormal de sang des cavités gauches aux cavités droites, entraînant une augmentation du débit pulmonaire.
- Normalement : il existe une égalité entre le débit pulmonaire et le débit systémique.



2) Risques :

- HTA pulmonaire
- Evolution possible vers une maladie vasculaire pulmonaire destructive irréversible

3) Conséquences cliniques:

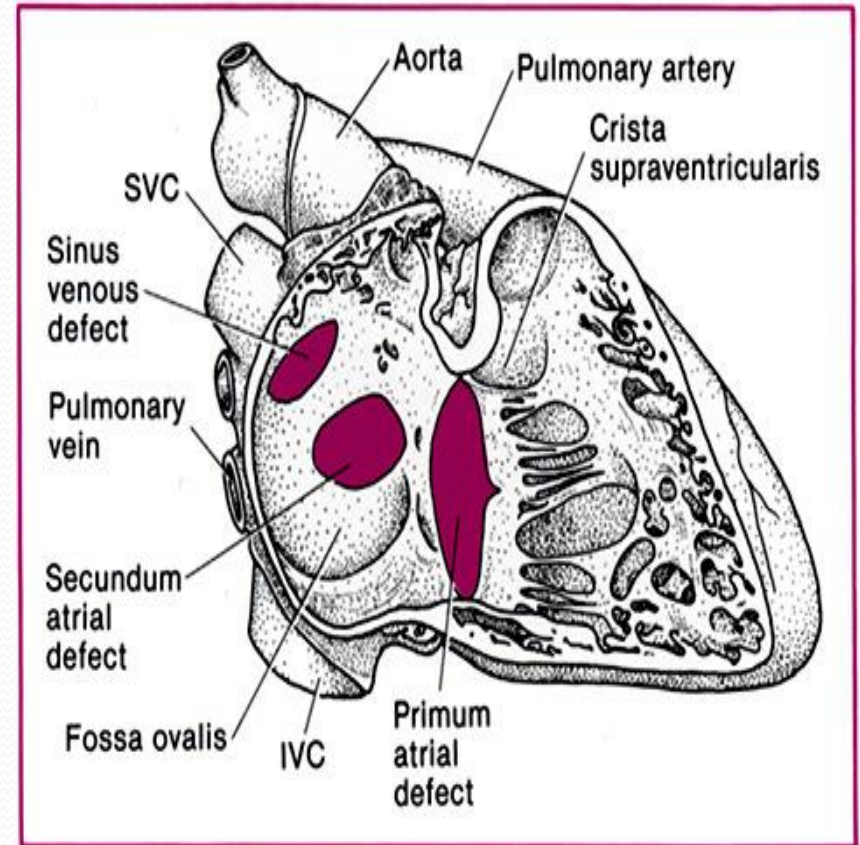
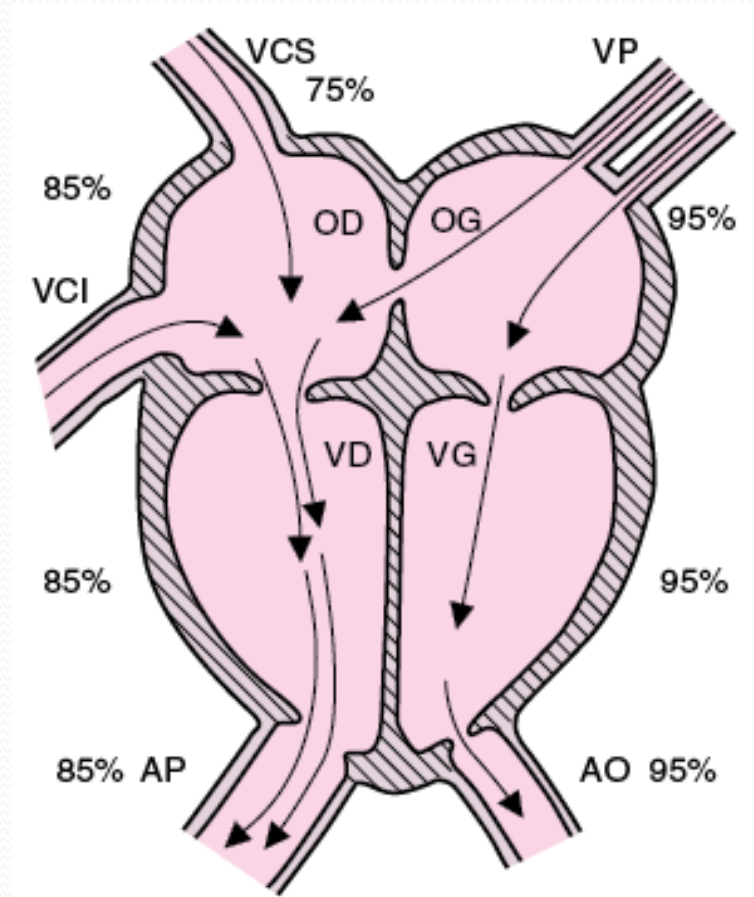
- Pléthore vasculaire pulmonaire : dyspnée, troubles respiratoire, ...
- Insuffisance du débit systémique : sueurs, hypotrophie
- Surcharge des ventricules : tachycardie, insuffisance cardiaque, cardiomégalie
- Hypervascularisation pulmonaire

COMMUNICATION INTERAURICULAIRE CIA

- Cardiopathie congénitale non cyanogène
- Défaut de développement de la cloison inter atriale mettant ainsi en communication les deux oreillettes.
- Plusieurs types anatomiques
- L'ETT est l'examen indispensable.

COMMUNICATION INTERAURICULAIRE

CIA



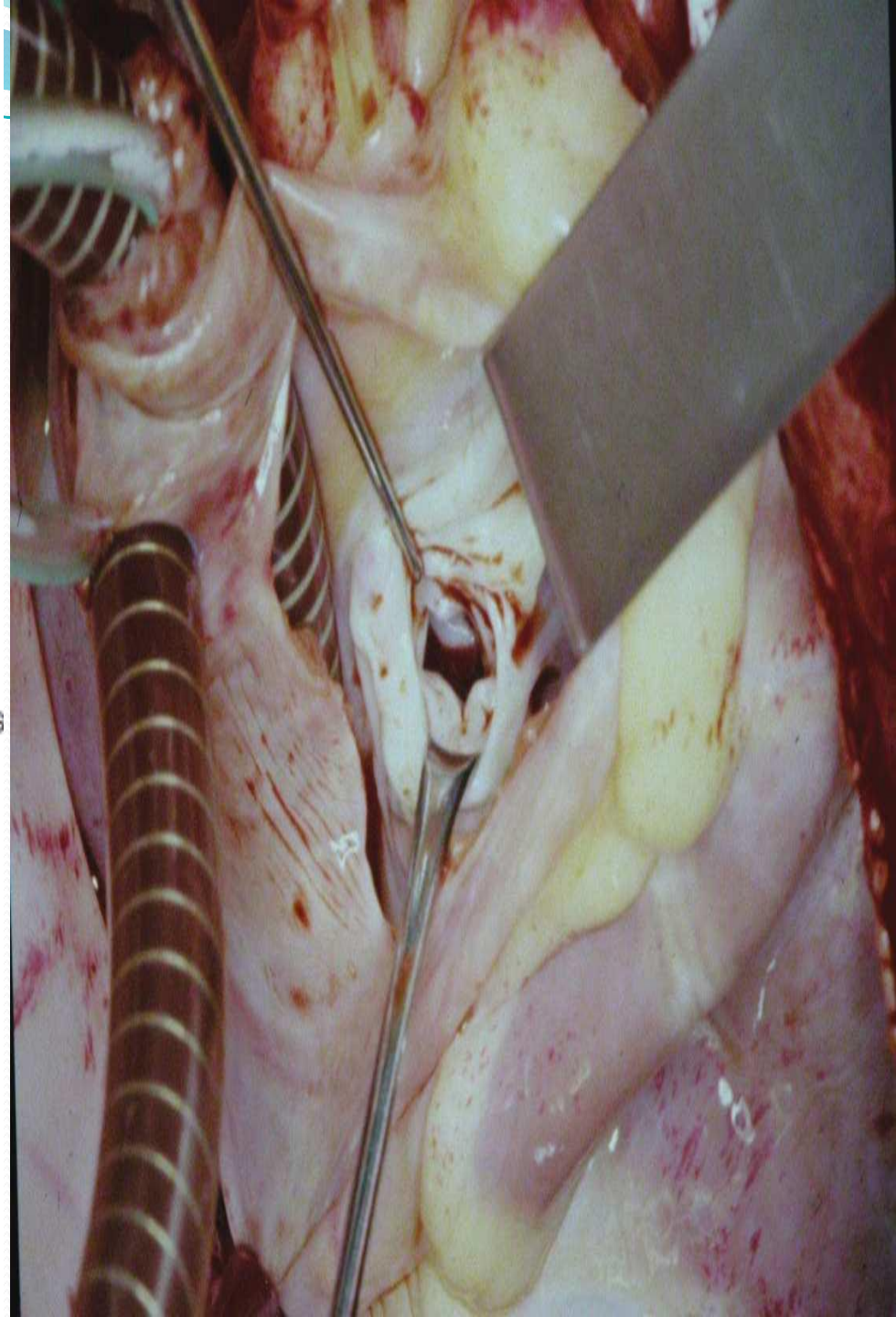
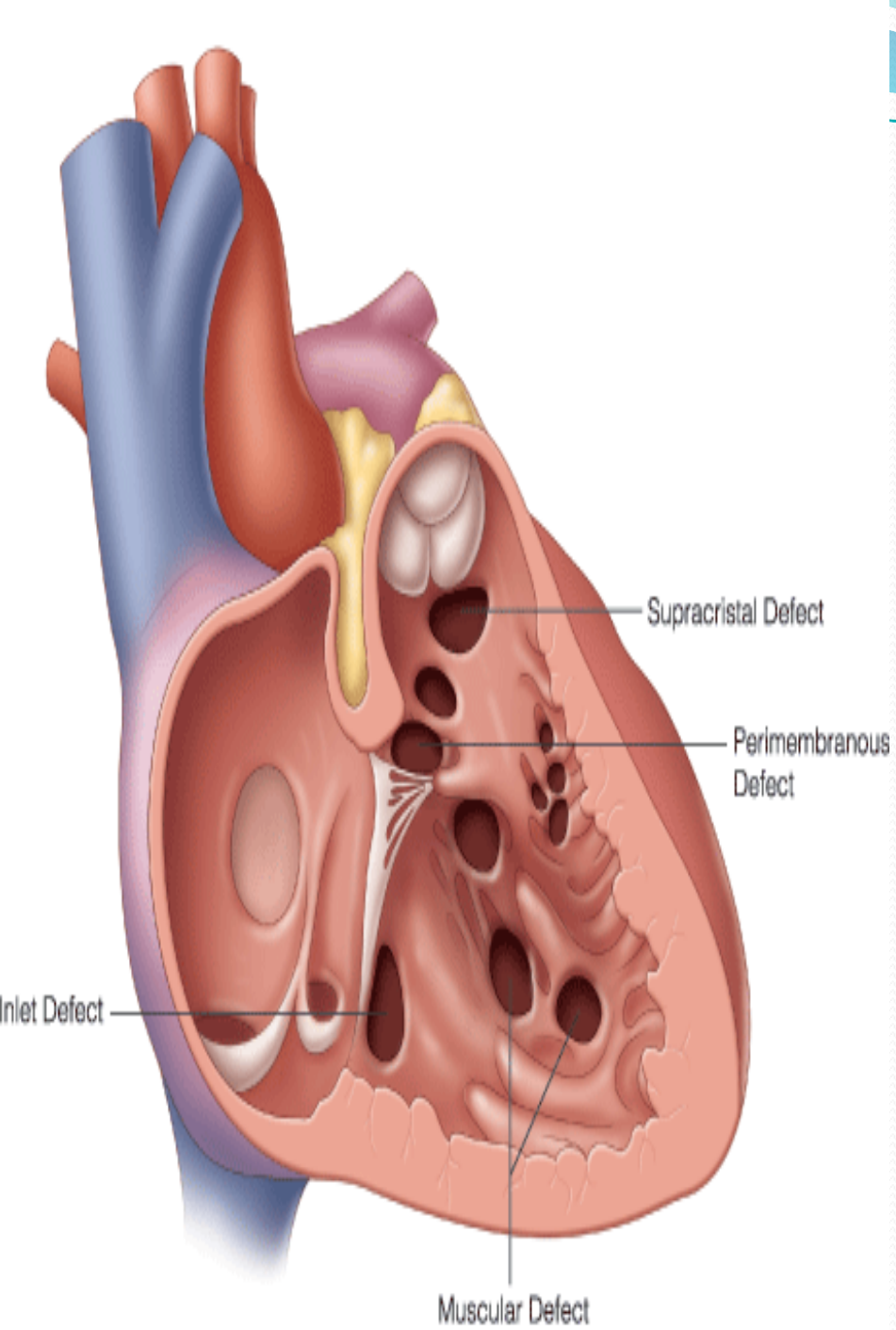
XI/ Communication inter-ventriculaires

1) Fréquence:

Représente 20 à 25% des cardiopathies congénitales.

2) Définition:

« Trou » entre les 2 ventricules ; communication anormale entre les ventricules.



3) Classification :

*Petites communications inter-ventriculaires :

- Bien supporté
- Souffle (flux anormal irrégulier)
- La plupart de ces communications se ferment seule
- Attention n à l'endocardite bactérienne

*Larges communications inter-ventriculaires :

- Enfant de quelques semaines+++
- Gros débit entraînant une surcharge pulmonaire



4) Evolution:

- Amélioration possible
- Aggravation (risque vital) vers la cyanose

5) Traitement :

- Diurétique (Lasilix)
- Digoxine
- Inhibiteur de l'enzyme de conversion
- Si aggravation :

Chirurgie palliative : cerclage de l'artère pulmonaire ou

Chirurgie curative : fermeture par patch.

6) Risques, complications

Pour toute communication inter-ventriculaire :

- Risque d'endocardite
- Insuffisance aortique

XII/ Malformations constructives

- *Obstacles à l'éjection du ventricule gauche
- *Obstacles à l'éjection du ventricule droit
- *Souffle systolique
- ***Diagnostic** : échographie

XIII/ Coarctation de l'aorte

A. Fréquence

Fréquent ; 5 à 8% des cardiopathies.

B. Définition

Rétrécissement de l'isthme de l'aorte : Obstacle entre la partie haute et la partie basse du corps :

- Pression trop élevée dans la partie haute du corps
- Pression trop faible dans la partie basse du corps

C. Clinique

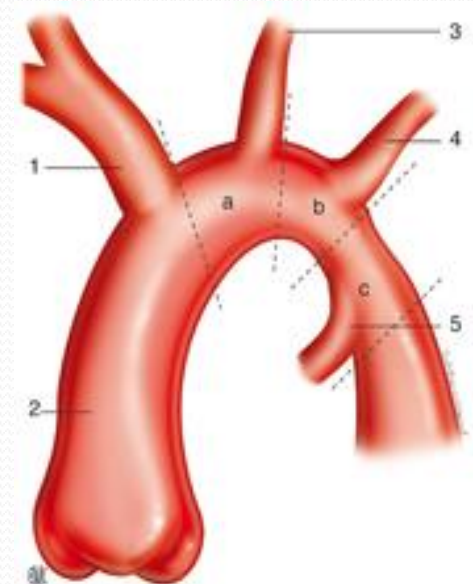
Souffle

HTA aux membres supérieurs

Diminution ou abolition des pouls fémoraux

D. Traitement

Chirurgical : on enlève la partie de l'aorte qui est rétrécie.



Tétralogie de Fallot

Fréquence:

La plus fréquente des cardiopathies cyanogènes

Définition: Malformation avec :

- Sténose pulmonaire étagée
- Aorte plus à droite
- Hypertrophie du ventricule droit
- Large communication inter- ventriculaire

Clinique: L'enfant est cyanosé car le sang peut passer d'une cavité à l'autre

Diagnostic: Echographie

Traitement: Chirurgical

Tétralogie de Fallot

